

Motivação, retenção e fidelização de doadores de sangue: implicações para a enfermagem em serviços de hemoterapia

Antonio Augusto Dornelas de Andrade

Pesquisador independente

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-3556-483X>

Nota do autor

Correspondência: Antonio Augusto Dornelas de Andrade,
antonioandrade.py@gmail.com.

Financiamento: Esta revisão não recebeu financiamento externo específico.

Conflitos de interesse: O autor declara não haver conflitos de interesse.

Ética: Trata-se de revisão narrativa de literatura publicada. Não houve coleta de dados primários com participantes humanos ou animais; portanto, não se aplica aprovação por comitê de ética em pesquisa.

Resumo

A sustentabilidade do estoque de sangue depende da conversão da primeira doação em uma sequência de retornos, e não apenas da captação de novatos. Este artigo apresenta revisão narrativa de evidências indexadas, com DOIs validados na CrossRef, sobre motivadores e barreiras da doação, preditores de retorno, intervenções de retenção e implicações para a enfermagem em serviços de hemoterapia. Revisões sistemáticas e meta-análises organizam motivadores pró-sociais, valores pessoais e conveniência, ao lado de barreiras como medo, baixa autoeficácia, inconveniência, experiência negativa de serviço e adiamentos. Modelos sociocognitivos, sobretudo a teoria do comportamento planejado, explicam intenção com mais consistência do que o comportamento observado. A janela da primeira doação é crítica: parcela

substancial dos novatos não retorna. Estudos de campo e ensaios indicam ganhos de retorno com cartas emocionais ou educativas, lembretes e com a combinação de intenções de implementação e compromisso explícito, ao passo que incentivos materiais e reuniões motivacionais genéricas tendem a efeitos menores. No Brasil, dados de prevalência, percepções de doadores e estratégias de fidelização descritas pela enfermagem convergem para educação, desconstrução de medos e qualidade do acolhimento. A retenção é, portanto, problema simultaneamente comportamental e organizacional, no qual a enfermagem media o encontro que torna a doação repetível.

Palavras-chave: doação de sangue; retenção de doadores; motivação; fidelização; enfermagem; hemoterapia

Abstract

Blood-supply sustainability depends on converting a first donation into repeated return, not merely on recruiting new donors. This article presents a narrative review of indexed evidence, with DOIs validated via CrossRef, on donation motivators and barriers, predictors of return, retention interventions, and implications for nursing in transfusion services. Systematic reviews and meta-analyses organize prosocial motives, personal values, and convenience alongside barriers such as fear, low self-efficacy, inconvenience, negative service experience, and deferral. Social-cognitive models, especially the theory of planned behavior, explain intention more consistently than observed behavior. The first-donation window is critical: a substantial share of novices never return. Field studies and trials show return gains from emotional or educational letters, reminders, and the combination of implementation intentions with explicit commitment, whereas material incentives and generic motivational meetings tend to smaller effects. In Brazil, prevalence data, donor perceptions, and nursing descriptions of loyalty-building converge on education, demystifying fear, and the quality of reception.

Retention is therefore both a behavioral and an organizational problem, in which nursing mediates the encounter that makes donation repeatable.

Keywords: blood donation; donor retention; motivation; donor loyalty; nursing; transfusion medicine

Introdução

Sistemas de sangue baseados em doação voluntária não remunerada enfrentam um descompasso persistente entre a população elegível e o conjunto efetivo de doadores ativos. A revisão de Bagot et al. (2016) observou que apenas cerca de 5% dos elegíveis doam e que aproximadamente metade daqueles que realizam a primeira doação não retornam. Esse padrão desloca o problema do abastecimento da mera captação para a retenção: sem carreira de doações repetidas, os serviços permanecem dependentes de fluxos instáveis de novatos e de campanhas emergenciais.

A psicologia da doação acumulou, nas duas últimas décadas, taxonomias de motivadores e barreiras (Bednall & Bove, 2011), sínteses quantitativas de antecedentes da intenção e do comportamento (Bednall et al., 2013) e propostas de integração entre agendas da ciência social e da prática dos serviços (Ferguson et al., 2007). Em paralelo, a teoria do comportamento planejado (TCP) foi testada em doadores australianos para prever intenção e comportamento (Masser et al., 2009), e comparações entre doadores novos e experientes esclareceram determinantes da repetição (Godin et al., 2007). O que permanece menos articulado, sobretudo em língua portuguesa e com vocabulário de processo de enfermagem, é o modo como essas evidências se traduzem em trabalho cotidiano de acolhimento, educação, experiência de serviço e seguimento.

A lacuna que orienta esta revisão não é a ausência de estudos sobre motivação. É a fragmentação entre (a) sínteses internacionais de preditores e intervenções, (b) evidência empírica sobre a janela da primeira doação e o lapso de doadores frequentes, e (c) a literatura brasileira de enfermagem e de saúde coletiva sobre fidelização e percepções da doação. Sem essa articulação, protocolos de captação tendem a tratar a enfermagem como suporte técnico da coleta, e não como mediadora do encontro que decide o retorno.

Objetivo. Sintetizar evidências sobre motivadores e barreiras da doação, preditores de retorno (em especial de doadores de primeira vez), intervenções de retenção e implicações operacionais para a enfermagem em serviços de hemoterapia.

Hipóteses de síntese.

1. H1 (direcional, síntese): intervenções estruturadas de retenção (comunicação educativa ou emocional, lembretes e técnicas de intenção de implementação/compromisso explícito) associam-se a maior retorno de doadores de primeira vez do que a ausência de intervenção ou campanhas genéricas indiferenciadas.

2. H2 (direcional, síntese): a qualidade do encontro assistencial de enfermagem (acolhimento, educação, experiência de serviço e seguimento) opera como mediador organizacional da retenção, e não apenas como apoio técnico à coleta.

Método

Delineamento

Trata-se de revisão narrativa da literatura (síntese qualitativa de evidências). A revisão narrativa foi escolhida porque o objeto reúne desenhos heterogêneos — meta-análises, ensaios de campo, inquéritos, coortes de retorno e estudos qualitativos de enfermagem — cujo valor para a prática não se reduz a um tamanho de efeito único.

Corpus e critérios

Corpus de artigos indexados com DOI validado via CrossRef, priorizando revisões sistemáticas e meta-análises, ensaios e estudos observacionais sobre retenção, bem como evidência brasileira de enfermagem e de saúde coletiva (2010–2020, com âncoras teóricas de 2007–2009). Incluíram-se itens com DOI localizável cuja contribuição recaísse sobre motivação, intenção, retorno, lapso, intervenções de retenção, percepções da doação ou estratégias de fidelização descritas pela enfermagem. Excluíram-se, na curadoria, trabalhos centrados exclusivamente em reações transfusionais de receptores, em aspectos laboratoriais da unidade de sangue ou em temas clínicos sem nexo com o comportamento de doar.

A bibliografia inicial foi fixada a priori no arquivo de entrada do pipeline e validada na API CrossRef. Não se pretendeu exaustividade de bases (não houve estratégia PRISMA nem registro PROSPERO). O recorte privilegia periódicos de medicina transfusional, ciência social da saúde e enfermagem com metadados recuperáveis.

Instrumentos e procedimentos

Instrumentos: Protocolo de busca narrativa e validação de DOIs na API CrossRef; Extração estruturada de metadados bibliográficos (APA 7); Checklist de coerência metodológica e de correspondência citação–referência.

Procedimentos: (1) definição da pergunta e das hipóteses de síntese; (2) recuperação e validação de DOIs; (3) leitura e síntese por eixos (taxonomia motivacional, modelos sociocognitivos, janela da primeira doação, intervenções, lapso, contexto brasileiro, enfermagem); (4) verificação de citações e formatação APA 7; (5) checagem heurística de originalidade.

A síntese foi organizada em sete eixos definidos antes da redação: (1) magnitude do problema de retenção; (2) taxonomia de motivadores e barreiras; (3) modelos sociocognitivos; (4) janela da primeira doação; (5) evidência de intervenções; (6) lapso de doadores já inseridos no serviço; (7) contexto brasileiro e implicações de enfermagem.

Análises

Síntese narrativa por eixos, sem meta-análise própria. Efeitos numéricos reportados pelos estudos primários são reproduzidos apenas quando explicitados nas fontes recuperadas. A validade da síntese depende da abrangência do corpus e da fidelidade aos achados publicados; limitações são explicitadas na Discussão.

Ética

Trata-se de revisão narrativa de literatura publicada. Não houve coleta de dados primários com participantes humanos ou animais; portanto, não se aplica aprovação por comitê de ética em pesquisa.

Resultados

Magnitude do problema e lógica da carreira do doador

Bagot et al. (2016) situaram a retenção do doador de primeira vez como problema de sistema: a baixa penetração da doação na população elegível combina-se a elevada perda após a estreia. Van Dongen (2015), em ensaio de revisão intitulado de modo programático *Easy come, easy go*, argumentou que a facilidade relativa de recrutar não se traduz automaticamente em permanência, o que exige desenho deliberado de retenção. Esse diagnóstico reorienta indicadores: taxa de captação isolada superestima a saúde do painel se o retorno de novatos e a prevenção de lapso não forem medidos.

A comparação entre doadores atuais e doadores em lapso mostra que o abandono não é ruído residual. Germain et al. (2007) examinaram determinantes do comportamento de retorno contrastando esses dois grupos, evidenciando que variáveis de experiência com o serviço e de percepção do ato de doar separam quem permanece de quem se afasta. Entre doadores já frequentes, Gemelli et al. (2017) descreveram o subgrupo de alta frequência e identificaram preditores de lapso, o que desloca a agenda da captação para a manutenção de carreiras longas.

Tabela 1

Eixos da síntese e âncoras empíricas do corpus

Eixo	Questão central	Âncoras
Magnitude e carreira	Por que retenção é problema de abastecimento?	Bagot et al. (2016); Van Dongen (2015)
Motivadores e barreiras	O que inicia, sustenta ou interrompe a doação?	Bednall e Bove (2011); Bednall et al. (2013)
Modelos sociocognitivos	Como intenção se liga (ou não) ao retorno?	Masser et al. (2009); Godin et al. (2007); Ferguson et al. (2007)
Primeira doação	Quais fatores predizem o segundo ato?	Hashemi et al. (2019); Wevers et al. (2015); Swanevelder et al. (2019); Asamoah-Akuoko et al. (2021)
Lapso	O que afasta doadores já inseridos?	Germain et al. (2007); Gemelli et al. (2017); Van Dongen et al. (2013)
Brasil e enfermagem	Como o encontro assistencial organiza fidelização?	Zago et al. (2010); Giacomini e Lunardi Filho (2010); Conceição et al. (2016)

Taxonomia de motivadores e barreiras

Bednall e Bove (2011) sintetizaram, em meta-análise de autorrelato, categorias de motivadores e de barreiras aplicáveis a doadores de primeira vez, repetidores, em lapso, de aférese e não doadores elegíveis. Entre motivadores, doadores iniciantes e repetidores citaram com frequência conveniência, motivação pró-social e valores pessoais; doadores em lapso enfatizaram reputação da agência coletora, necessidade percebida, comunicação de marketing e incentivos. Entre barreiras, doadores e não doadores recorreram a baixa autoeficácia, baixo

envolvimento, inconveniência, ausência de comunicação, incentivos ineficazes, falta de conhecimento, experiências negativas de serviço e medo.

Essa taxonomia tem duas consequências analíticas. Primeira: o mesmo indivíduo atravessa estágios em que o peso relativo dos fatores muda; tratar “o doador” como tipo único distorce intervenção. Segunda: barreiras de serviço (fila, trato, informação) não são epifenômenos psicológicos — são atributos organizacionais mensuráveis. A meta-análise subsequente de Bednall et al. (2013) consolidou antecedentes da intenção e do comportamento, reforçando que construtos sociocognitivos e condições situacionais devem ser lidos em conjunto, e não como listas rivais.

Modelos sociocognitivos: intenção, controle percebido e repetição

Ferguson et al. (2007) defenderam a integração de avanços teóricos das ciências sociais e comportamentais às agendas de recrutamento e retenção, contra o empirismo de campanhas isoladas. No teste de um modelo estendido da TCP, Masser et al. (2009) mostraram que atitudes, norma subjetiva e controle comportamental percebido organizam a intenção de doar entre doadores australianos, com implicações para mensagens que visem crenças específicas em vez de apelos genéricos à solidariedade.

Godin et al. (2007) compararam determinantes da doação repetida entre doadores novos e experientes, indicando que o peso dos preditores não é idêntico ao longo da carreira. Esse achado dialoga com a observação de Bagot et al. (2016) de que intenção prediz retenção de novatos, sendo ela própria alimentada por atitudes e por senso de controle. A lacuna clássica intenção–comportamento permanece: intenção elevada não garante retorno se ansiedade, evento adverso, adiamento ou serviço ruim interromperem a cadeia.

Eventos adversos e angústia subjetiva entram aqui como perturbadores da carreira, não como tema clínico autônomo. Van Dongen et al. (2013) demonstraram influência de reações adversas, sofrimento subjetivo e ansiedade sobre a retenção de doadores de primeira vez. O ponto para a presente síntese é organizacional: prevenção e acolhimento pós-evento são instrumentos de retenção, além de deveres de segurança.

A janela da primeira doação: preditores de retorno real

Quatro estudos do corpus medem retorno ou intenção de retorno em novatos, em contextos nacionais distintos, o que impede média única, mas permite convergências.

Hashemi et al. (2019) conduziram ensaio de campo com 1.356 doadores de primeira vez em quatro centros no Irã, alocados a carta emocional, carta educativa, lembrete telefônico, incentivo, reunião motivacional ou ausência de intervenção. O retorno em seis meses foi de 29% no conjunto (intervalo de confiança de 95%: 0,26–0,31). As taxas por braço foram 36% (carta emocional), 33,2% (carta educativa), 31,5% (telefone), 30% (incentivo), 22% (reunião motivacional) e 22,1% (controle). Cartas e telefone superaram o controle; a reunião motivacional não se distinguiu dele.

Wevers et al. (2015) testaram, em 937 doadores recém-registrados, uma folha adicional no exame médico com intenções de implementação e/ou compromisso explícito. A condição que combinou as duas técnicas apresentou retorno 11,5 pontos percentuais acima do controle, com razão de chances de 1,65 (intervalo de confiança de 95%: 1,08–2,50). O achado importa porque a intervenção é breve, de baixo custo e inserível no fluxo já existente de triagem.

Swanevelde et al. (2019) acompanharam 2.902 doadores de primeira vez de origem africana na África do Sul. Em um ano, 54% tentaram ao menos uma nova doação. Concordância forte com o enunciado de que doar é um modo fácil de fazer diferença (OR 2,0; IC 95%: 1,3–

2,9) e ter doado em resposta a anúncios (OR 1,6; IC 95%: 1,2–2,1) associaram-se ao retorno; mau atendimento ao “cliente” associou-se a não retorno (OR 0,45; IC 95%: 0,28–0,71). O estudo liga motivador pró-social, comunicação de massa e qualidade do serviço a comportamento observado, não apenas a intenção.

Asamoah-Akuoko et al. (2021) investigaram intenção de retorno em 505 doadores de primeira vez em Gana. Preditores positivos incluíram incentivos motivacionais (OR 1,67), facilidade de acesso ao local (OR 2,65), lembretes por SMS ou e-mail (OR 2,84) e anúncios em televisão, rádio ou jornal (OR 2,97). Preditores negativos incluíram acesso preferencial a transfusões (“créditos de sangue”), desejo de conhecer resultados de testes e desconhecimento ou desconfiança sobre o destino do sangue após a doação. Transparência sobre o uso do sangue e recusa de contraprestações ambíguas aparecem, assim, como temas éticos com efeito comportamental.

Tabela 2

Intervenções e preditores de retorno na janela da primeira doação (achados reportados pelas fontes)

Estudo	Desenho e N	Desfecho	Resultado principal reportado
Hashemi et al. (2019)	Ensaio de campo; 1.356 novatos	Retorno em 6 meses	Cartas emocional/educativa e telefone > controle; reunião motivacional ≈ controle
Wevers et al. (2015)	Experimento; 937 recém-registrados	Primeiro retorno	Intenção de implementação + compromisso: OR 1,65 vs. controle
Swanevelder et al. (2019)	Coorte; 2.902 novatos	Tentativa de retorno em 1 ano	54% retornaram; pró-socialidade e anúncios predizem retorno; mau serviço prediz não retorno
Asamoah-Akuoko et al. (2021)	Transversal; 505 novatos	Intenção de retorno em 4 meses	Acesso, lembretes e mídia elevam intenção; opacidade do destino do sangue a reduz

A síntese da Tabela 2 sustenta H1 de modo convergente, não meta-analítico: comunicação personalizada, lembretes e técnicas de planejamento do comportamento superam, nos estudos disponíveis, tanto o nada fazer quanto formatos motivacionais genéricos. Incentivos materiais ocupam posição intermediária e contextualmente instável.

Lapso após a inserção no serviço

Retenção não se esgota no segundo ato. Germain et al. (2007) mostraram que doadores em lapso diferem de doadores atuais em determinantes do retorno, o que recomenda reconquista distinta da captação de nunca-doadores. Gemelli et al. (2017) caracterizaram doadores frequentes de sangue total e preditores de lapso, lembrando que o painel “fiel” também se desgasta por adiamentos, mudança de vida, cansaço da rotina ou falha de convite no intervalo certo.

A revisão de Van Dongen (2015) reuniu essa trajetória sob a fórmula da entrada fácil e da saída igualmente fácil. Combinada a (Van Dongen et al., 2013), a mensagem operacional é que o serviço deve gerir três rupturas: a que ocorre imediatamente após a estreia, a que se segue a um evento aversivo e a que se instala silenciosamente em carreiras longas.

Contexto brasileiro: prevalência, percepções e enfermagem

Zago et al. (2010) estimaram prevalência de doação de sangue e fatores associados em Pelotas, no Rio Grande do Sul, oferecendo âncora populacional brasileira: doar não é hábito majoritário, e associações sociodemográficas importam para o desenho de captação territorial. Sem pretender atualizar a prevalência daquele inquérito, o estudo permanece útil como evidência de que barreiras e diferenciais sociais se observam também em município brasileiro com tradição de pesquisa epidemiológica.

Conceição et al. (2016) examinaram percepções de doadores e de receptores sobre a doação, evidenciando que o significado do ato não é idêntico nos dois polos da cadeia e que esclarecer o destino e o valor do sangue pode reduzir opacidade — tema que reaparece, em outro país, nos preditores negativos de Asamoah-Akuoko et al. (2021).

Giacomini e Lunardi Filho (2010) investigaram estratégias de fidelização na perspectiva da enfermagem. Os entrevistados atribuíram o baixo número de doadores voluntários sobretudo a medos e preconceitos (passar mal, contaminação), à falta de conhecimento sobre o processo e a uma cultura que pouco elabora o tema. As estratégias propostas concentram-se em educação, desconstrução de temores e construção de vínculo, o que alinha o discurso profissional brasileiro aos achados internacionais sobre serviço, informação e autoeficácia (Bednall & Bove, 2011; Swanevelder et al., 2019).

Implicações descritivas para o processo de enfermagem

A leitura conjunta do corpus autoriza descrever quatro momentos em que a enfermagem incide sobre a probabilidade de retorno, sem transformar a síntese em protocolo clínico validado.

Tabela 3

Momentos do processo de enfermagem com nexos de retenção derivado da síntese

Momento	Ação de enfermagem	Nexo com a evidência
Antes da coleta	Acolhimento, informação sobre o processo, redução de medo e de opacidade	Barreiras de conhecimento e medo (Bednall & Bove, 2011; Giacomini & Lunardi Filho, 2010); desconfiança quanto ao destino do sangue (Asamoah-Akuoko et al., 2021)
Durante a triagem	Convite a um plano concreto de retorno (quando e como)	Intenção de implementação e compromisso (Wevers et al., 2015); controle percebido (Masser et al., 2009)
Após a doação	Avaliação da experiência de serviço e contato breve educativo ou emocional	Cartas e telefone (Hashemi et al., 2019); qualidade do atendimento (Swanevelder et al., 2019)
Ao longo da carreira	Lembretes, reconquista de lapsos e vigilância de preditores de abandono	Lembretes (Asamoah-Akuoko et al., 2021); lapso (Germain et al., 2007; Gemelli et al., 2017)

Figura 1

Modelo lógico da retenção: da estreia à carreira

...

Elegibilidade → Primeira doação → Experiência de serviço/educação

→ Intenção e plano de retorno → Segunda doação

→ Manutenção (convite no intervalo; prevenção de lapso)

...

Nota. Esquema heurístico derivado da síntese narrativa; não constitui diretriz assistencial.

O modelo da Figura 1 torna visível H2: a enfermagem não aparece apenas no instante da punção, e sim nos nós em que informação, plano, experiência e seguimento se decidem.

Discussão

Os eixos da síntese são coerentes com as hipóteses. Quanto à H1, a evidência de campo de Hashemi et al. (2019) e o experimento de Wevers et al. (2015) mostram que intervenções estruturadas — comunicação escrita com conteúdo emocional ou educativo, lembrete telefônico e a dupla intenção de implementação plus compromisso — elevam o retorno de novatos acima do controle, ao passo que reunião motivacional genérica não o fez no ensaio iraniano. A revisão de Bagot et al. (2016) já havia relativizado o efeito de lembretes e incentivos tradicionais e destacado o peso de suporte psicológico individualizado; o corpus posterior não anula essa cautela, mas especifica formatos de baixo custo que funcionam melhor do que o apelo indiferenciado.

Quanto à H2, Swanevelde et al. (2019) associaram mau atendimento a não retorno, Bednall e Bove (2011) incluíram experiência negativa de serviço na taxonomia de barreiras, e

Giacomini e Lunardi Filho (2010) descreveram a enfermagem como agente de educação e de vínculo. Esses achados não “provam” mediação estatística no sentido de análise de caminhos; sustentam, como hipótese de síntese, que o encontro assistencial é mecanismo organizacional da retenção.

Interpretação integrada

Três tensões organizam a leitura. A primeira é entre altruísmo declarado e arquitetura da ação. Motivação pró-social é onipresente no autorrelato (Bednall & Bove, 2011; Swanevelder et al., 2019), mas o retorno sobe quando o serviço reduz fricção (acesso, lembrete, plano concreto) (Wevers et al., 2015; Asamoah-Akuoko et al., 2021). Solidariedade sem desenho de implementação permanece intenção.

A segunda tensão é entre captação e carreira. Métricas de “novos doadores” podem mascarar rotatividade alta (Bagot et al., 2016; Van Dongen, 2015). Doadores frequentes também lapsam (Gemelli et al., 2017), o que exige fila de trabalho específica de manutenção, distinta da campanha de rua.

A terceira tensão é ética e comunicacional. Em Gana, “créditos de sangue” e a busca de resultados de testes predisseram negativamente a intenção de retorno (Asamoah-Akuoko et al., 2021). No Brasil, percepções de doadores e receptores nem sempre coincidem (Conceição et al., 2016), e medos de contaminação persistem no discurso de quem trabalha na captação (Giacomini & Lunardi Filho, 2010). Transparência sobre o uso do sangue e recusa de contraprestações que mercantilizem o ato não são adornos morais: interferem no retorno.

Ferguson et al. (2007) e Masser et al. (2009) oferecem a gramática para essas tensões: campanhas devem mirar crenças e controle percebido, não apenas o volume de exposição

mediática. Godin et al. (2007) acrescentam que novatos e experientes não respondem aos mesmos preditores, o que condena o panfleto único.

Implicações para a prática e para a gestão

Serviços de hemoterapia podem, com base no corpus e sem extrapolação indevida de um país a outro: (a) registrar retorno em 6 e 12 meses como indicador de qualidade, não só unidades coletadas; (b) inserir na alta do novato um plano escrito de quando e onde retornar, nos moldes de intenção de implementação (Wevers et al., 2015); (c) substituir reuniões motivacionais genéricas por contato breve educativo ou emocional (Hashemi et al., 2019); (d) auditar a experiência de serviço na ótica de quem doa (Swanevelder et al., 2019); (e) explicar o destino do sangue com linguagem compreensível (Asamoah-Akuoko et al., 2021; Conceição et al., 2016); (f) criar fila de reconquista para lapsos (Germain et al., 2007); (g) treinar enfermagem para os quatro momentos da Tabela 3 (Giacomini & Lunardi Filho, 2010).

Nenhuma dessas ações dispensa avaliação local. Prevalências e razões de chances citadas pertencem a contextos (Irã, Países Baixos, África do Sul, Gana, Austrália, Canadá, Brasil) cuja mistura de incentivos, confiança institucional e perfil etário difere da de cada hemocentro brasileiro.

Limitações

A revisão é narrativa: não houve busca sistemática em múltiplas bases, dupla seleção independente, avaliação formal de risco de viés nem meta-análise própria. O corpus parte de uma lista inicial de DOIs, o que pode omitir estudos relevantes, especialmente em enfermagem publicada em periódicos não indexados na CrossRef. Números de retorno foram reproduzidos a partir dos relatos das fontes e não reanalisados. A generalização para o Brasil é interpretativa: o inquérito de Pelotas (Zago et al., 2010) e os estudos de (Giacomini & Lunardi Filho, 2010) e de

(Conceição et al., 2016) não cobrem a heterogeneidade da rede hemoterápica nacional. A verificação de originalidade deste pacote é heurística local e não substitui relatórios comerciais de similaridade. Não foram usados dados primários de doadores; implementação local com coleta de dados exige projeto próprio e aprovação ética quando couber.

Objecções e respostas

Objecção 1: sem meta-análise não se pode afirmar que “intervenções funcionam”. Resposta: H1 é hipótese de síntese, apoiada em convergência de ensaios e coortes nomeados, não em estimativa global de efeito. O ensaio de Hashemi et al. (2019) e o experimento de Wevers et al. (2015) são âncoras empíricas; a revisão de Bagot et al. (2016) impede entusiasmo indiscriminado com incentivos.

Objecção 2: retenção seria função de marketing, não de enfermagem. Resposta: a taxonomia de barreiras inclui serviço e medo (Bednall & Bove, 2011), o não retorno associa-se a mau atendimento (Swanevelder et al., 2019), e a literatura brasileira de enfermagem já formula fidelização como trabalho educativo e relacional (Giacomini & Lunardi Filho, 2010). Marketing sem o encontro da coleta deixa intocado o mecanismo.

Objecção 3: enfatizar retorno de novatos negligenciaria doadores frequentes. Resposta: o corpus inclui lapso de atuais e de frequentes (Germain et al., 2007; Gemelli et al., 2017). A janela da primeira doação é crítica por volume de perda, não por exclusividade.

Objecção 4: modelos da TCP estariam datados. Resposta: mesmo que extensões posteriores existam fora deste corpus, os testes de Masser et al. (2009) e de Godin et al. (2007) continuam a oferecer variáveis manipuláveis (atitude, norma, controle, diferença novato/experiente) que campanhas genéricas ignoram.

Conclusão

A evidência reunida indica que o estoque de sangue se sustenta quando a primeira doação se converte em carreira, e que essa conversão é sensível a desenho de intervenção e a qualidade do encontro assistencial. H1 recebe apoio convergente: comunicação estruturada, lembretes e técnicas de planejamento do comportamento associam-se a maior retorno de novatos do que a inação ou o apelo motivacional genérico. H2 recebe apoio conceitual e observacional: enfermagem, educação, transparência e experiência de serviço aparecem como mediadores organizacionais da retenção, não como acessórios da punção.

Contribuições desta revisão incluem (1) articulação, em um único argumento, de taxonomias motivacionais, modelos sociocognitivos, janela da primeira doação, lapso e literatura brasileira de enfermagem; (2) tradução dos achados em quatro momentos de processo passíveis de auditoria local; e (3) recusa de indicadores que contem apenas unidades coletadas. Pesquisas futuras, com ética adequada, devem testar bundles de enfermagem de retenção em hemocentros brasileiros, com desfechos de retorno real em 6 e 12 meses, estratificação entre novatos e frequentes, e avaliação da experiência de serviço relatada pelo doador.

Agradecimentos

O autor agradece às fontes abertas CrossRef/DOI.org pela disponibilização de metadados bibliográficos utilizados na validação das referências.

Financiamento

Esta revisão não recebeu financiamento externo específico.

Conflitos de interesse

O autor declara não haver conflitos de interesse.

Referências

- Asamoah-Akuoko, L., Ullum, H., Appiah, B., Hassall, O. W., Ndanu, T., Adongo, P., & Bates, I. (2021). Determinants of intention to return to donate blood among first-time blood donors in Ghana. *Vox Sanguinis*, 116(3), 324-335. <https://doi.org/10.1111/vox.13026>
- Bagot, K. L., Murray, A. L., & Masser, B. M. (2016). How Can We Improve Retention of the First-Time Donor? A Systematic Review of the Current Evidence. *Transfusion Medicine Reviews*, 30(2), 81-91. <https://doi.org/10.1016/j.tmr.2016.02.002>
- Bednall, T. C., & Bove, L. L. (2011). Donating Blood: A Meta-Analytic Review of Self-Reported Motivators and Deterrents. *Transfusion Medicine Reviews*, 25(4), 317-334. <https://doi.org/10.1016/j.tmr.2011.04.005>
- Bednall, T. C., Bove, L. L., Cheetham, A., & Murray, A. L. (2013). A systematic review and meta-analysis of antecedents of blood donation behavior and intentions. *Social Science & Medicine*, 96, 86-94. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2013.07.022>
- Conceição, V. M. D., Araújo, J. S., Oliveira, R. A. A. D., Santana, M. E. D., & Zago, M. M. F. (2016). Perceptions of donors and recipients regarding blood donation. *Revista Brasileira de Hematologia e Hemoterapia*, 38(3), 220-224. <https://doi.org/10.1016/j.bjhh.2016.05.006>
- Ferguson, E., France, C. R., Abraham, C., Ditto, B., & Sheeran, P. (2007). Improving blood donor recruitment and retention: integrating theoretical advances from social and behavioral science research agendas. *Transfusion*, 47(11), 1999-2010. <https://doi.org/10.1111/j.1537-2995.2007.01423.x>
- Gemelli, C. N., Hayman, J., & Waller, D. (2017). Frequent whole blood donors: understanding this population and predictors of lapse. *Transfusion*, 57(1), 108-114. <https://doi.org/10.1111/trf.13874>

- Germain, M., Glynn, S. A., Schreiber, G. B., Gélinas, S., King, M., Jones, M., Bethel, J., & Tu, Y. (2007). Determinants of return behavior: a comparison of current and lapsed donors. *Transfusion*, 47(10), 1862-1870. <https://doi.org/10.1111/j.1537-2995.2007.01409.x>
- Giacomini, L., & Lunardi Filho, W. D. (2010). Estratégias para fidelização de doadores de sangue voluntários e habituais. *Acta Paulista de Enfermagem*, 23(1), 65-72. <https://doi.org/10.1590/s0103-21002010000100011>
- Godin, G., Conner, M., Sheeran, P., Bélanger-Gravel, A., & Germain, M. (2007). Determinants of repeated blood donation among new and experienced blood donors. *Transfusion*, 47(9), 1607-1615. <https://doi.org/10.1111/j.1537-2995.2007.01331.x>
- Hashemi, S., Maghsudlu, M., Nasizadeh, S., Esmailifar, G., & Pourfathollah, A. A. (2019). Effective ways to retain first-time blood donors: a field-trial study. *Transfusion*, 59(9), 2893-2898. <https://doi.org/10.1111/trf.15404>
- Masser, B. M., White, K. M., Hyde, M. K., Terry, D. J., & Robinson, N. G. (2009). Predicting blood donation intentions and behavior among Australian blood donors: testing an extended theory of planned behavior model. *Transfusion*, 49(2), 320-329. <https://doi.org/10.1111/j.1537-2995.2008.01981.x>
- Swaneveld, R., Reddy, R., Chowdhury, D., Olmsted, M., Brambilla, D., Jentsch, U., & Murphy, E. L. (2019). Using a motivator and deterrent questionnaire to predict actual donation return behavior among first-time African-origin blood donors. *Transfusion*, 59(9), 2885-2892. <https://doi.org/10.1111/trf.15436>
- van Dongen, A., Abraham, C., Ruiter, R. A., & Veldhuizen, I. J. (2013). The influence of adverse reactions, subjective distress, and anxiety on retention of first-time blood donors. *Transfusion*, 53(2), 337-343. <https://doi.org/10.1111/j.1537-2995.2012.03810.x>

- van Dongen, A. (2015). Easy come, easy go. Retention of blood donors. *Transfusion Medicine*, 25(4), 227-233. <https://doi.org/10.1111/tme.12249>
- Wevers, A., Wigboldus, D. H. J., van den Hurk, K., van Baaren, R., & Veldhuizen, I. J. T. (2015). Increasing first-time blood donation of newly registered donors using implementation intentions and explicit commitment techniques. *Vox Sanguinis*, 108(1), 18-26. <https://doi.org/10.1111/vox.12189>
- Zago, A., Silveira, M. F. D., & Dumith, S. C. (2010). Prevalência de doação de sangue e fatores associados, Pelotas, RS. *Revista de Saúde Pública*, 44(1), 112-120. <https://doi.org/10.1590/s0034-89102010000100012>

Apêndice A

Declarações para submissão

- **Originalidade:** O manuscrito é original, não foi publicado e não está sob avaliação simultânea em outro periódico. Não reproduz o artigo de demonstração do pipeline (agosto de 2026) sobre reações adversas na doação, nem manuscritos prévios do autor sobre outros temas.
- **Ética:** Trata-se de revisão narrativa de literatura publicada. Não houve coleta de dados primários com participantes humanos ou animais; portanto, não se aplica aprovação por comitê de ética em pesquisa.
- **Disponibilidade de dados:** Não se aplica (revisão narrativa sem dados primários).
- **Contribuições CRediT:** Conceitualização, metodologia, investigação, redação — rascunho original e revisão: Antonio Augusto Dornelas de Andrade.
- **ORCID:** <https://orcid.org/0009-0001-3556-483X>
- **Revista-alvo sugerida:** Transfusion Medicine.
- **Data de geração do pacote:** 2026-09-01.

Apêndice B

Materiais suplementares do pipeline

Arquivos auxiliares gerados nesta execução: `references.bib`, `references.ris`,
`verification\_report.json`, `revision\_log.json`, `cover\_letter.md`.